

Transdiagnostyczny *model Fairburna*

Rdzeń bulimii — nadmierne znaczenie wagi i kształtu w samoocenie. Z rdzenia wynika reszta cyklu. Model wspólny dla BN, BED i AN. Fundament leczenia CBT-E.

CZAS: 20 min · psychoedukacja podstawowa · Sesja 1-2 · zanim wprowadzi się techniki

ŹRÓDŁO: Fairburn, Cooper & Shafran (2003); Fairburn (2008, „Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders“)

JAK UŻYWAĆ

Zrozum **rdzeń modelu Fairburna** i jego sześć elementów (sekcje 1-2), poznaj **jak rdzeń napędza cykl** (sekcja 3). Sekcja 4 — Twoja konceptualizacja: rozpoznaj swoje elementy modelu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Fairburn, Cooper i Shafran (2003): wszystkie zaburzenia odżywiania — bulimia (BN), zaburzenie z napadami objadania (BED), anoreksja (AN), zaburzenia subkliniczne (OSFED) — mają **wspólny rdzeń poznawczy: nadmierne znaczenie wagi i kształtu w samoocenie** (ang. *overvaluation of weight and shape*). U osób bez ED samoocena opiera się na wielu obszarach. U osób z ED samoocena **nieproporcjonalnie** opiera się na wadze i kształcie ciała. To *nie* jest „próżność” — to **schemat poznawczy**, który napędza cały cykl. Fairburn (2008) opracował na tej podstawie CBT-E (*Enhanced Cognitive Behavior Therapy*) — terapię z największą bazą dowodów dla bulimii (40-60% pełna remisja w RCT, Fairburn i in. 2009). Zrozumienie modelu przez pacjenta jest **fundamentem** leczenia.

01 ◎ Rdzeń modelu — czym jest *overvaluation*

SAMOOOCENA U OSOBY BEZ ED

Wiele filarów: relacje, praca, hobby, wartości, kreatywność, charakter. Jeden filar może się zachwiać, ale całość pozostaje stabilna. *Waga to drobny fragment.*

SAMOOOCENA W BULIMII

Dominujący filar: **waga i kształt**. Inne obszary są ścieśnione, zaniedbane. Każde wahanie wagi = wahanie samoceny. Wąska baza = niestabilność.

Konsekwencja: jeśli Twoja samoocena *w największym stopniu* zależy od wagi/kształtu — każda zmiana ciała (rzeczywista lub wyimaginowana) zachwieje Twoim poczuciem wartości. Powstaje silna potrzeba *kontroli* wagi → reguły żywieniowe → cykl objadań i kompensacji. Rdzeń pozostaje **jeśli się go nie zaadresuje** — nawet po remisji objadania.

02 📋 Sześć elementów modelu

1 · RDZEŃ — *overvaluation*

Nadmierne znaczenie wagi/kształtu w samoocenie. Wąska baza. Mechanizm centralny.

2 · REGUŁY ŻYWIENIOWE

Sztwyne zasady: „*nie wolno*”, „*tylko do...*”, „*po 18:00 nie*”. Próba kontroli przez restrykcję.

3 · ŁAMANIE REGUŁ

Sztwyne reguły są nieosiągalne. Złamanie jednej → myślenie *wszystko-albo-nic*.

4 · EPIZOD OBJADANIA

Utrata kontroli nad jedzeniem. Subiektywne lub obiektywne. Reakcja na restrykcję, nie „*brak*”

5 · KOMPENSACJA

Wymioty, środki przeczyszczające, ćwiczenia, kolejna głódówka. Próba

6 · WZMOCNIENIE RDZENIA

Wstyd → jeszcze silniejsza fokusacja na wadze → wąska baza samooceny → silniejszy rdzeń. Pętla.

03 Jak rdzeń napędza cykl

Rdzeń (waga jako miara wartości) → **Reguły** (próba kontroli) → **Restrykcja** (biologiczna i psychologiczna deprivacja) → **Złamanie reguły** (myślenie wszystko-albo-nic) → **Epizod** (utrata kontroli) → **Wstyd, lęk** → **Kompensacja** (chwilowa ulga) → powrót do **Reguły** (silniej) → rdzeń się umacnia.

Klucz: kompensacja (wymioty, środki, ćwiczenia, głodówka) *nie* jest rozwiązaniem — jest **częścią problemu**. Każde „cofnięcie” epizodu utrwala cykl, bo daje chwilową ulgę i wzmacnia przekonanie, że można „kontrolować” konsekwencje. To pułapka: im więcej kompensacji, tym silniejsza restrykcja → większe ryzyko kolejnego epizodu. Leczenie CBT-E celuje w *kilka* miejsc tego cyklu jednocześnie: rdzeń (sesje 9–20), regularne jedzenie (sesje 2–6), kompensacje (sesje 2–4).

04 Moja konceptualizacja — rozpoznaj swoje elementy

MÓJ RDZEŃ — CO NAJSILNIEJ KSZTAŁTUJE MOJĄ SAMOOCENĘ

— np. waga, wygląd, sukcesy, relacje; oceń proporcje

MOJE REGUŁY ŻYWIENIOWE

— jakie zasady mam wobec jedzenia? co „nie wolno”?

MÓJ CYKL — OPISZ TYPOWY ŁAŃCUCH

— co jest u Ciebie pierwsze, co następne; gdzie widzisz potencjalne punkty interwencji

Klucz: model Fairburna **nie** jest moralną oceną — to *opis mechanizmu*. Bulimia nie jest „słabością charakteru”, „próżnością” ani „brakiem dyscypliny”. To **poznawczy schemat**, który napędza behawioralny cykl. Tak samo jak nikt nie obwinia osoby z depresją za jej myśli automatyczne, nie obwiniaj siebie za rdzeń poznawczy bulimii. Fairburn i in. (2009, RCT z 154 pacjentkami): CBT-E (40 sesji w 20 tygodni) prowadzi do **pełnej remisji u 40-60%** osób z BN, z efektem utrzymującym się w obserwacji 60-tygodniowej. Adresowanie *tylko* behawioralnej części cyklu (jedzenia, kompensacji) bez pracy z rdzeniem prowadzi do wczesnych nawrotów. **Praca z rdzeniem** — czyli poszerzanie bazy samooceny o inne obszary życia — jest *długoterminowa*, ale to ona daje trwałą zmianę.